

Wundversorgung im Systemkonflikt

Medizinische Evidenz vs. Wirtschaftlichkeitsdruck & Regressrisiko der Hausärzte (§ 12 SGB V)

Kernproblem in der Hausarztpraxis: Hausärzte unterliegen einem starren Verordnungsbudget. Das System belastet dem Arztkonto den künstlich hohen Apotheken-Listenpreis (*Lauertaxe*) voll an, während Krankenkassen im Hintergrund geheime Herstellerrabatte kassieren. Aus Angst vor persönlichen Regressen verordnen Ärzte oft vermeintlich billige Standardverbände (z. B. Mepilex XT), was das Gesamtsystem durch zusatznotwendiges Material und häufigere Wechsel teurer zu stehen kommt.

1. KLINISCHER PRODUKTVERGLEICH: ALLEVYN VS. MEPILEX (STANDARD)

ALLEVYN Life / Gentle Border (Smith & Nephew)

- **Technologie:** Hydrozellulärer Polyurethanschäum mit integriertem *Superabsorber-Verschlusskern* und maskierender Außenschicht (EXUMASK®).
- **Exsudatmanagement:** Bewältigt mäßige bis starke, zähflüssige Exsudatmengen. Schließt Flüssigkeit vertikal & horizontal sicher ein (keine Mazeration).
- **EXUMASK® Wechselindikator:** Patentiertes Kleeblatt-Muster zeigt Sättigung präzise an. Verhindert unnötige Kontrollwechsel auf Verdacht.
- **All-in-One Saugspeicher:** *KEIN zusätzliches Saugmaterial (Zetuvit) oder Fixierband erforderlich!*
- **Wechselintervall:** Verbleibt **4–5 Tage** sicher auf der Wunde.

Mepilex XT / Standard (Mölnlycke)

- **Technologie:** Standard-Polyurethanschäum mit Safetac®-Silikonbeschichtung.
- **Hautschutz:** Goldstandard für pergamentartige, feine Hautränder bei schwacher Exsudation oder Dekubitus-Prophylaxe.
- **Exsudat-Limitierung:** *Besitzt KEINEN Superabsorber-Kern.* Läuft bei hohem Exsudat rasch aus und mazeriert das Wundumfeld.
- **Zusatzmaterial-Zwang:** *Erfordert zwingend sekundäre Saugkompressen (Zetuvit E) + Fixierfolien (Fixomull).*
- **Wechselintervall:** Muss bei Exsudation alle **1–2 Tage** gewechselt werden.

2. DAS KOSTEN- & ABRECHNUNGS-PARADOXON (LAUERTAXE VS. REALMARKT)

Zwischen den Preisen auf dem Kassenrezept und dem freien Markt klafft eine systembedingte Lücke:

- **Kassen-Listenpreis (Lauertaxe):** Gesetzlicher Höchstpreis (~180 € bis >500 €/Packung). Sichert Apotheken & Großhandel feste Margen und belastet das Arztbudget voll.
- **Geheime Rabattverträge:** Krankenkassen zahlen real nicht den Listenpreis, sondern erhalten vertrauliche Rückerstattungen der Hersteller.
- **Online-Großhandel (Selbstzahler):** Großhandelsrabatte werden direkt weitergegeben (Preise oft 50–70 % unter der Lauertaxe, ~190 €).

Das Hausarzt-Dilemma: Praxissoftware-Systeme bewerten Produkte starr nach dem Kassen-Listenpreis des Einzelverbands und markieren billige Basisprodukte mit einem 'grünen Symbol'. Die Software ignoriert dabei völlig, dass das billige Basisprodukt zwingend teures Zusatzmaterial nach sich zieht!

3. VOLLSTÄNDIGE MATHEMATISCHE KOSTENGEGENÜBERSTELLUNG (4 WOCHEN)

Klinischer Befund: Dekubitus Stadium 3 (stark exsudierend & stark belegt). Betrachtungszeitraum: 4 Wochen (28 Tage).

Kostenposition / Produkt	Methode 1: Günstig-Stückliste (Mepilex XT + Zusatzmaterial)	Methode 2: ALLEVYN Life (All-in-One Kombi-Therapie)
Wechselintervall & Frequenz	3x wöchentlich (12 Wechsel)	2x wöchentlich (8 Wechsel)
Primärverband / Schaumverband	Mepilex XT (10x10 cm, 12 Stk.): 282,00 €	ALLEVYN Life (10,3x10,3 cm, 8 Stk.): 223,00 €
Reinigung / Debridement	Cutimed Sorbact (12 Stk.): 78,00 €	Cutimed Sorbact (8 Stk.): 52,00 €
Sekundärer Saugspeicher	Zetuvit E (12 Stk.): 18,00 €	0,00 € (Superabsorber integriert!)
Fixierung / Folienverband	Fixomull stretch (anteilig): 18,00 €	Fixomull (anteilig): 12,00 €
MATERIALKOSTEN (ARZT-BUDGET)	396,00 €	287,00 € (-109,00 € / -27,5 %)
PFLEGEDIENST-EINSEITZE (SGB V)	12 Einsätze (hohe Personalkosten)	8 Einsätze (-33 % Behandlungspflege)

Systemfehler-Analyse: Methode 2 (ALLEVYN Life) spart dem Gesamtsystem real **109,00 € Materialkosten** und **33 % Pflegedienstzeit**. Die Prüfsoftware des Arztes erkennt jedoch nur den höheren Einzelpreis des Kombiverbands und warnt fälschlicherweise vor einer Budgetüberschreitung!

4. DIE LOGIKLÜCKE (§ 12 SGB V) & DAS SYSTEMISCHE SILO-PARADOXON

Nach § 12 SGB V schulden Krankenkassen nur eine 'ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche' Versorgung (*Schulnote 4*). Dies führt zu einem teuren Effizienz-Paradoxon:

- **Silo-Denken der Kostenträger:** Materialkosten belasten das Budget des Hausarztes (GKV), Personalkosten für den Pflegedienst belasten die Pflegeversicherung oder Krankenbehandlungspflege. Eine Gesamtkostenbetrachtung findet nicht statt.
- **Getarnte Zusatzkosten:** Viele 'günstige' Einzelkomponenten (Mepilex + Zetuvit + Fixomull) fliegen unter dem Radar der automatisierten Softwarekontrolle, verursachen aber in Summe höhere Material- und Behandlungspflegekosten.
- **Effizienz durch Innovation:** Der EXUMASK®-Wechselindikator von ALLEVYN verhindert unnötige Verdachts-Wechsel, verlängert das Intervall auf 5 Tage und reduziert den Materialverbrauch um **60 %**.

5. STRATEGISCHER LEITFADEN ZUR REGRESSVERMEIDUNG FÜR HAUSÄRZTE

Prozesskette zum 100 % Regresschutz: Pflegedienst erstellt Evidenz -> Hausarzt heftet Dokumentation in Patientenakte -> Kassenprüfung wird abgewendet.

1. **Patientenspezifische Evidenz:** Wundprotokoll inklusive Fotodokumentation durch den zertifizierten Wundmanager (ICW®) erstellen.
2. **Versagensnachweis der Standardtherapie:** Schriftlicher Beleg, dass Mepilex / Standard-Schaumstoff ohne Superabsorber bei hohem Exsudat nach 24 Std. ausläuft, Mazerationen verursacht und zwingend teures Zusatzmaterial erfordert.
3. **Mathematischer Effizienznachweis:** Vorlage der Kostengegenüberstellung (Senkung der Wechselhäufigkeit von 3x auf 2x pro Woche = 109,00 € Ersparnis).
4. **Sonderstatus deklarieren:** Der Arzt deklariert die Verordnung ab Dekubitus Stadium 3 oder Wunddauer > 8 Wochen als **belegte Praxisbesonderheit**.

6. PRAXIS-SPRECHZETTEL FÜR DAS HAUSARZTGESPRÄCH

Nutzen Sie diese Formulierung im Dialog mit dem Hausarzt:

"Herr/Frau Doktor [Name], ich kenne das Problem mit den engen Budgets und der Regressgefahr. Die aktuelle Basisversorgung mit dem einfachen Schaumverband funktioniert jedoch klinisch und wirtschaftlich nicht mehr: Der Verband läuft aus, wir haben Mazerationen und müssen dreimal die Woche wechseln sowie teure Saugkompressen dazukaufen.

Ich habe die Gesamtkosten durchgerechnet: Wenn wir auf ALLEVYN Life umstellen, senken wir die Wechsel auf zweimal pro Woche. Durch den integrierten Superabsorber sparen wir uns die Zusatz-Saugkompressen komplett. In Summe entlasten wir Ihr Materialbudget um über 100 Euro im Monat und sparen 33 % Pflegediensteinsätze.

Damit Sie bei einer Wirtschaftlichkeitsprüfung völlig sicher sind und kein Regressrisiko haben, habe ich Ihnen die Wunddokumentation, die Fotos und die genaue Kostenaufstellung mitgebracht. Wenn Sie das in die Patientenakte heften, ist die Verordnung als Praxisbesonderheit absolut wasserdicht dokumentiert."

AERIS Wundmanagement & Pflegeberatung • Inhaber: René Krieg (Pflegefachmann, ICW® Wundexperte, Pain Nurse, Beatmungstherapeut)
Hohenfelsstraße 34, 35232 Dautphetal • Telefon: 06466 / 911 320 • E-Mail: rene.krieg@aeris-pflege.de